

TEMA 1.4 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Herida, Escaras, Cicatrices Patológicas

PERFIL EUNACOM 4.01.2.025

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Manejo General de Heridas

El tratamiento estándar de las heridas (cortantes, avulsiones o colgajos) incluye sistemáticamente ciertos pilares para evitar la sepsis, optimizar la cicatrización y minimizar las secuelas estéticas.

1. Aseo de la Herida y Uso de Antisépticos

El método fundamental para la limpieza y aseo de la herida preexistente es el flujo profuso de **suero fisiológico o agua**. La intención es lograr un "barrido" de la tierra y los restos orgánicos de la zona. - **Uso de antisépticos locales:** - La clorhexidina se puede utilizar para complementar el barrido profundo inicial si es quirúrgico. - Povidona yodada y alcohol **nunca deben aplicarse sobre las heridas abiertas**. Presentan toxicidad y generan más daño necrótico celular en la propia lesión que su beneficio bactericida. Solo se usan para purificar la **piel íntegra sana** previo a una primera incisión en un contexto quirúrgico.

2. Vacunación y Profilaxis Antitetánica

Se debe garantizar la indemnidad inmunológica en todo perfil de impacto que rompa la piel cutánea (mordeduras, quemaduras, cortes). Dependiendo de si la persona guarda en su registro el uso del "toxóide antitetánico": - **Menos de 10 años desde la última dosis:** Completamente protegido, no se hace nada. - **Más de 10 años:** Un refuerzo inmunológico ("booster"). - **Esquema incompleto o ningún registro en su vida:** Iniciar esquema profiláctico estricto en tres dosis (Día 0, 1 mes, 2 meses post-día 0). - **Herida Masiva y francamente contagiada/sucia + Nunca vacunado:** Se aplica protocolo de esquema clásico en dosis junto con **inmunoglobulina antitetánica** simultánea.

3. Terapia con Antibióticos Sistémicos

El uso de antibióticos solo está indicado ante la presentación de heridas masivas, o que posean franca visibilidad de tierra, pus local inicial, edema, olor fétido y/o un proceso supurativo en la zona, es decir o francamente sucias o infectadas clínicamente.

4. Sutura

- **Jamás se cierra o sutura una herida sucia (tierra residual) o infectada** para no favorecer el ambiente anaeróbico focal intracavitario ni atrapar el microorganismo. - Aquellas heridas que sean abrasivas por tracción no pueden ser sometidas a sutura por pérdida de lecho basal. - **Manejo de hemorragia inicial:** Frente a un origen activo, la **compresión mecánica primaria focal** gana prioridad frente a establecer los puntos o usar material sintético. Solo requerirá ligadura de emergencia intrahospitalaria si el flujo es marcadamente arterial. - **Técnicas según estética:** - Si es en un área blanda facial o zona estéticamente importante de corta longitud en niños y adultos, el enfoque es siempre la **sutura intradérmica** (reduce la forma hipertrófica en zigzag del punto corrido). Estas siempre deben usarse con materiales biológicamente absorbibles por debajo de la dermis profunda superficial. - Las hebras *no absorbibles* (nylon) se instalan típicamente en tegumento externo que planea retirarse idealmente frente al 7mo o 10mo día evolutivo.

Úlceras por Presión (Escaras o Úlceras de Decúbito)

Representa la necrosis originada por la caída vascular prolongada tras estancamiento o inmovilidad que presiona a la piel contra una cama o asiento en los focos vulnerables óseos anatómicos subyacentes.

Escala en Grado de Profundidad Clínica y Pronóstico

1. **Grado 1:** La estructura dérmica es contigua. El área manifiesta un gran eritema plano que "no blanquea", con rubor, calor e inflamación pero ninguna úlcera al exponerse. 2. **Grado 2:** Disrupción epitelial primaria llegando al lecho total de la dermis. 3. **Grado 3:** Ruptura con cavidad y compromiso de la hipodermis o grasa subcutánea. Se constata frecuentemente "esfacelos" (fibrina solidificada pálida muerta). 4. **Grado 4:** Llegada necrótica y expuesta al tejido muscular subfascial y visualización del tendón de Aquiles, inserciones osteomusculares o huesos directos, marcando comorbilidad por potencial inicio con **osteomielitis**.

Esquema Terapéutico General del Manejo de Escaras

El tratamiento es en su mayor parte la prevención clínica

constante: - Imposición estricta intrahospitalaria de giros posturales y movilizaciones constantes (cada 30 min — 2 hr máximo). - Utilización de camas antiescaras (como ayuda pero no como reemplazo de los cambios decúbitos).

• Algoritmos de las Heridas Actuales por Presión:

- No habiendo ningún componente infeccioso superpuesto e independientemente del grado destructivo que abarque, el mecanismo indicado de remoción de los trozos negros y desvitalizados se llama **debridamiento químico y físico curatorio** (mediante pomadas ricas en desbridantes colagenasas, lidocaína o hidrogeles).
- Si se considera necesaria la **Debridación Quirúrgica inmediata** junto con **fármacos antimicrobianos en dosis agresiva prolongada** cuando la herida se encuentra "infectada clínicamente" (bordes eritematosos e hinchados con fiebre purulenta grave) y en estadios patogénicos irreversibles masivos o de resistencia al tejido cicatricial grado IV. De existir una osteomielitis asociada se procede indefectiblemente siempre al quirófano agresivo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Recordar un pilar médico clave: Una escara jamás requiere tratamiento antibiótico a menos de que esté infectada, a pesar de que presente tejido desvitalizado, pus local perianal, entre otras variables que no califiquen con componente de diseminación celular general sintomatológica.

Trastornos y Cicatrices Patológicas

Existen defectos en el manejo de la reconstrucción e interconectividad que resultan en secuelas post-traumáticas.

1. Queloides

Una respuesta reparativa genéticamente patológica del recubrimiento epitelial caracterizada por **sobrepasar agresivamente los bordes de la herida e irregularidad dimensional excesiva**. Su tratamiento no responde favorablemente al procedimiento solo quirúrgico debido al recrudescimiento recidivante perenne que posee el ADN de las áreas locales, requiriendo **parches de silicona largos profilácticos** pos-escaotomización local superficial con infiltración de terapias corticales crónicas.

2. Cicatriz Hipertrófica

Es de fisiopatología netamente mecánica y funcional producto de una tensión forzada masiva (como cuando la tracción original es obligada asimétricamente) al momento de confrontar los pedículos de la lesión sin tener en cuenta o liberar a las fuerzas retóricas contrarias, presentándose con engrosamiento y relieve sin salida o exterioridad transbasal. Es decir, **respetar los bordes de la lesión**

inicial. No suele presentar tasa recidivante una vez desenganchados e instalados re-suficientemente por los principios fundamentales de la incisión atraumática.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una paciente de setenta y cinco años, postrada por accidente vascular encefálico, presenta una úlcera sacra con fibrina amarilla visible y tejido necrótico que llega hasta el tejido celular subcutáneo. No hay eritema perilesional ni pus. ¿Cuál es el grado y el tratamiento de primera línea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Herida, Escaras, Cicatrices Patológicas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El aseo de heridas se hace con suero fisiológico; los antisépticos como alcohol y povidona yodada no se usan en heridas existentes por su daño celular.
- La vacuna antitetánica se indica en todas las heridas: si hace más de diez años de la última dosis hay que dar un booster; si nunca se vacunó y la herida está sucia, también inmunoglobulina.
- Las escaras se clasifican de grado uno a cuatro según profundidad; el tratamiento fundamental es la prevención con cambios de posición cada treinta minutos.
- El desbridamiento de escaras es químico con hidrogel en lesiones no infectadas; quirúrgico si hay infección, grado tres sin mejoría o grado cuatro con osteomielitis.
- El queloide sobrepasa los bordes de la herida original, tiene causa genética y alta residiva; se trata con resección más parche de silicona.
- La cicatriz hipertrófica respeta los bordes de la herida, es de causa mecánica por exceso de tensión, y se trata con sutura sin tensión.
- Las suturas absorbibles se usan en planos internos y en suturas intradérmicas; las no absorbibles se retiran a los siete días de la superficie.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HERIDA, ESCARAS, CICATRICES PATOLÓGICAS)

PREGUNTA 1

Una paciente de setenta y cinco años, postrada por accidente vascular encefálico, presenta una úlcera sacra con fibrina amarilla visible y tejido necrótico que llega hasta el tejido celular subcutáneo. No hay eritema perilesional ni pus. ¿Cuál es el grado y el tratamiento de primera línea?

- A)** Grado dos, curaciones con suero fisiológico
- B)** Grado tres, desbridamiento químico con hidrogel
- C)** Grado cuatro, cirugía urgente
- D)** Grado tres, antibióticos de amplio espectro y cirugía
- E)** Grado uno, cambios de posición y colchón antiescara

PREGUNTA 2

Una paciente de cuarenta años consulta porque tiene una cicatriz en el abdomen tras una cesárea hace dos años. Refiere que la cicatriz creció más allá del borde de la herida y ahora mide cuatro centímetros, mientras que la herida original era de dos centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento más adecuado?

- A)** Cicatriz hipertrófica, sutura sin tensión
- B)** Queloide, resección quirúrgica más parche de silicona
- C)** Queloide, corticoides tópicos sin cirugía
- D)** Cicatriz hipertrófica, parche de silicona
- E)** Infección de herida, antibióticos sistémicos

PREGUNTA 3

Un niño de ocho años llega a urgencias con una herida cortante de seis centímetros en la mejilla derecha. La herida está limpia, sin cuerpos extraños. Su madre dice que su última vacuna antitetánica fue hace quince años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Aseo con povidona yodada, sutura con punto corrido, sin vacuna
- B)** Aseo con suero fisiológico, sutura intradérmica, booster antitetánico
- C)** Aseo con clorexidina, no suturar, sin vacuna
- D)** Aseo con alcohol, sutura con nylon, inmunoglobulina antitetánica
- E)** Solo curaciones, sin sutura ni vacuna porque la herida está limpia

RESUMEN: HERIDA, ESCARAS, CICATRICES PATOLÓGICAS

El manejo de heridas incluye cinco pilares: aseo con suero fisiológico para remover contaminantes, vacuna antitetánica según esquema, antibióticos solo en heridas sucias, masivas o infectadas, sutura cuando la herida es cortante, grande, profunda o deformante, y curaciones con suero fisiológico. Los antisépticos como el alcohol y povidona yodada no se usan en heridas existentes porque dañan las células. La clorexidina sí puede usarse. Las suturas se dividen en absorbibles para planos profundos e internas, y no absorbibles para piel superficial. Las escaras o úlceras por presión se clasifican en grado uno a cuatro según profundidad. Grado uno es eritema sin disrupción de piel. Grado dos llega hasta la dermis. Grado tres hasta la hipodermis o con esfacelo. Grado cuatro compromete músculo, tendón u hueso con riesgo de osteomielitis. El tratamiento fundamental es la prevención con cambios de posición cada treinta minutos. El desbridamiento es químico con hidrogel para lesiones no infectadas, y quirúrgico cuando hay infección, lesiones grado tres que no curan, o grado cuatro con osteomielitis. Las cicatrices patológicas son el queloide y la cicatriz hipertrófica. El queloide es de causa genética y sobrepasa los bordes de la herida inicial. La cicatriz hipertrófica es por exceso de tensión y respeta los bordes. El queloide tiene alta residiva y se trata con parche de silicona tras resección. La cicatriz hipertrófica tiene mejor pronóstico y se trata con buena sutura sin tensión.